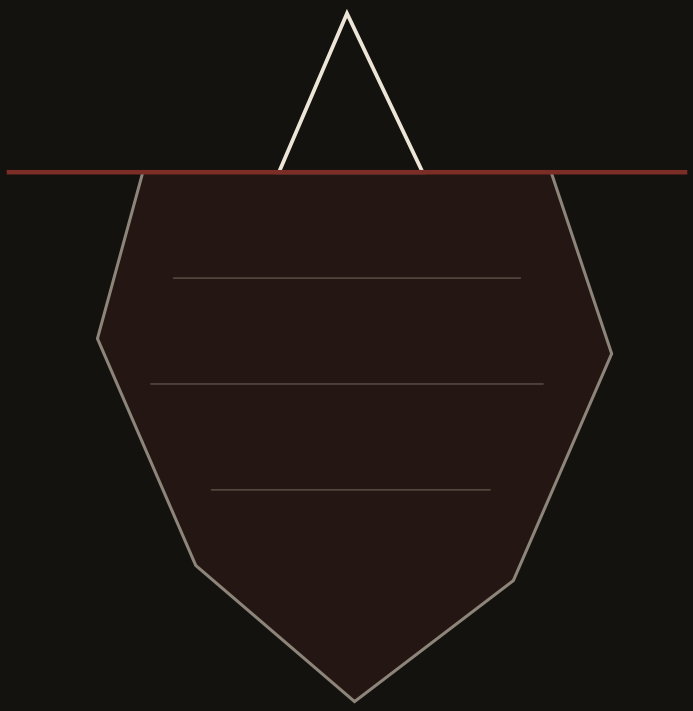
PSYCHOANALYSIS · 1856 – 1939



میراث فروید

روانکاوی، ناخودآگاه و فلسفهٔ انسان

زیگموند فروید

۱۸۵۶ – ۱۹۳۹

فهرست

۰۱ زندگی و زمینهٔ فکری ۳

۰۲ ناخودآگاه: قارهٔ پنهان ۵

۰۳ ساختار روان: نهاد، من و فرامن ۷

۰۴ غریزه‌ها: لیبیدو، اروس و سائق مرگ ۹

۰۵ رشد روانی‌ـجنسی ۱۰

۰۶ عقدهٔ ادیپ ۱۱

۰۷ اضطراب و سازوکارهای دفاعی ۱۲

۰۸ رؤیا: راه شاهانه به ناخودآگاه ۱۴

۰۹ روان‌رنجوری، هیستری و علامت ۱۶

۱۰ روانکاوی به‌مثابه روش درمان ۱۸

۱۱ زندگی روزمره، شوخی و هنر ۱۹

۱۲ فرهنگ، دین و تمدن ۲۰

۱۳ سوگ، مالیخولیا و خودشیفتگی ۲۲

۱۴ جانشینان و شاخه‌های روانکاوی ۲۳

۱۵ نقد، ارزیابی و میراث ۲۵

— پیوست الف: گاهشمار ۲۷

— پیوست ب: واژه‌نامه ۲۹

— پیوست پ: کتاب‌شناسی ۳۱

هر فصل با یک بخش «ارزیابی امروز» پایان می‌یابد؛ در آن میان آنچه فروید ادعا کرد و آنچه پژوهش‌های بعدی تأیید، اصلاح یا رد کرده‌اند جدا شده است. متن، ادعای فروید را از داوری امروز تفکیک می‌کند تا هر دو روشن باشند.

۰۱
زندگی و زمینهٔ فکری

روانکاوی پیش از آنکه نظریه باشد، پاسخ یک عصب‌شناس بود به پرسشی که آناتومی جوابش را نداشت: چرا بیماری که هیچ آسیب جسمی ندارد، فلج می‌شود، نمی‌بیند یا نمی‌تواند راه برود؟

زیگموند فروید ۶ مه ۱۸۵۶ در فرایبرگ موراویا (امروز پشیبور در جمهوری چک) در خانواده‌ای یهودی به دنیا آمد. در چهار سالگی با خانواده به وین رفت و تقریباً تمام عمرش را در همان شهر گذراند. در سال ۱۸۸۱ از دانشگاه وین دکترای پزشکی گرفت و سال‌ها در آزمایشگاه ارنست بروکه (Ernst Brücke) به پژوهش در فیزیولوژی عصبی مشغول بود. این پیشینه مهم است: بروکه و مکتب هلمهولتس معتقد بودند پدیده‌های زنده را باید با نیرو و انرژی توضیح داد. تصویر «انرژی روانی» که بعدها در نظریهٔ لیبیدو می‌بینیم، میراث همین نگاه است.

از شارکو تا درمان با گفتار

در زمستان ۱۸۸۵–۱۸۸۶ فروید در پاریس نزد ژان‌مارتن شارکو (Charcot) ماند. شارکو نشان می‌داد هیستری بیماری واقعی است، نه تظاهر؛ و با هیپنوتیزم می‌توان علائم جسمی آن را پدید آورد و برطرف کرد. نتیجهٔ ضمنی این بود که علائم جسمی می‌توانند ریشهٔ روانی داشته باشند. فروید به وین بازگشت و با یوزف بروئر (Josef Breuer) همکاری کرد. بیمار مشهور آنها، «آنا او» (Anna O.؛ نام واقعی او برتا پاپنهایم)، درمان خود را «درمان با گفتار» نامید: وقتی خاطره‌ای فراموش‌شده همراه با هیجان‌اش به زبان می‌آمد، علامت کم می‌شد. حاصل این همکاری کتاب «مطالعاتی دربارهٔ هیستری» (۱۸۹۵) بود.

خودکاوی و تولد روانکاوی

در دههٔ ۱۸۹۰ فروید از هیپنوتیزم دست کشید و روش «تداعی آزاد» را جایگزین کرد. دوستی نزدیک او با ویلهلم فلیس (Wilhelm Fliess) و مکاتبات‌شان تا ۱۹۰۲، ثبت‌کنندهٔ این دورهٔ جست‌وجو است. پس از مرگ پدرش در اکتبر ۱۸۹۶، فروید به خودکاوی سیستماتیک روی آورد؛ رؤیاهای خودش دادهٔ اصلی «تعبیر رؤیا» شد. این کتاب در نوامبر ۱۸۹۹ منتشر شد، اما تاریخ ۱۹۰۰ را بر پیشانی دارد.

از ۱۹۰۲ گروهی از پزشکان و اهل فرهنگ هر چهارشنبه در منزل او گرد می‌آمدند؛ این گروه ۱۹۰۸ به «انجمن روانکاوی وین» و ۱۹۱۰ به «انجمن بین‌المللی روانکاوی» بدل شد. جدایی آدلر (۱۹۱۱) و یونگ (۱۹۱۳) نخستین شکاف‌های جنبش بود. جنگ جهانی اول و روان‌رنجوری‌های جنگی، فروید را به بازنگری در نظریهٔ غریزه‌ها کشاند و محصول آن «فراسوی اصل لذت» (۱۹۲۰) بود.

سال‌های پایانی

از ۱۹۲۳ سرطان فک او آغاز شد و تا پایان عمر بیش از سی عمل جراحی را پشت سر گذاشت. نازی‌ها در ۱۹۳۳ کتاب‌های او را سوزاندند؛ پس از الحاق اتریش (مارس ۱۹۳۸) با کمک دوستان و شاگردانش به لندن مهاجرت کرد. چهار خواهر سالخوردهٔ او که در وین ماندند، در جریان هولوکاست کشته شدند. فروید ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۹ در لندن درگذشت.

چهار ریشهٔ فکری

(۱) فیزیولوژی ماده‌گرای قرن نوزدهم؛ (۲) تکامل‌گرایی داروین، که انسان را در امتداد طبیعت می‌دید؛ (۳) روان‌پزشکی و هیپنوتیزم فرانسوی (شارکو و ژانه)؛ (۴) ادبیات و اسطوره، از سوفوکل و شکسپیر تا گوته. نزدیکی فکری او با شوپنهاور و نیچه نیز مشهور است، هرچند خودش می‌گفت آنها را مستقیم نخوانده بود.

ارزیابی امروز

تاریخ‌نگاری جدید (الینبرگر، سالووی، گی) نشان می‌دهد روایت «کاشف تنها» اغراق‌آمیز است؛ ایده‌های ناخودآگاه و جنسیت پیش از فروید هم در جریان بود. سهم فروید در نظام‌مند کردن آنها و ساختن یک روش درمانی و یک زبان نظری یکپارچه است، و این سهم انکارناپذیر است.

۰۲

ناخودآگاه: قارهٔ پنهان

فروید می‌گفت انسان سه ضربهٔ بزرگ به خودشیفتگی‌اش خورده است: کوپرنیک او را از مرکز جهان برداشت، داروین او را از جایگاه ویژه‌اش میان جانداران، و روانکاوی نشان داد «من در خانهٔ خود ارباب نیست».

ادعای بنیادی روانکاوی این است که بخش بزرگی از زندگی روانی بیرون از آگاهی جریان دارد و رفتار، احساس و علائم ما را تعیین می‌کند. این ایده در تاریخ فکر پیشینه دارد (لایب‌نیتس، هربارت، شوپنهاور، فون هارتمان، ژانه)، اما فروید تصویر تازه‌ای از آن ساخت: ناخودآگاه **مخزن غیرفعال خاطره‌ها** نیست، **صحنهٔ نیروهای فعال** است. محتوای سرکوب‌شده فشار می‌آورد تا به آگاهی برسد و بخش سانسورگر روان آن را پس می‌زند. آنچه می‌بینیم (رؤیا، لغزش زبان، علامت بیماری) محصول این کشمکش است.

مدل مکان‌نگارانه (۱۹۰۰)

در فصل هفتم «تعبیر رؤیا» فروید روان را به سه ناحیه تقسیم کرد: خودآگاه، پیش‌آگاه و ناخودآگاه. تمثیل مشهور «کوه یخ» برای شرح همین مدل به کار می‌رود (خود فروید این تصویر را نساخت).



ویژگی‌های ناخودآگاه

فروید در مقالهٔ «ناخودآگاه» (۱۹۱۵) منطق این ناحیه را از منطق آگاهی جدا می‌کند. در ناخودآگاه نفی وجود ندارد؛ زمان معنا ندارد و گذشته با حال یکی است؛ تناقض مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ و واقعیت روانی جای واقعیت بیرونی را می‌گیرد. او این شیوهٔ کار را «فرایند نخستین» (Primary Process) می‌نامد که با دو ابزار پیش می‌رود: **تراکم** (چند معنا در یک تصویر) و **جابه‌جایی** (انتقال بار هیجانی از یک چیز به چیزی بی‌خطرتر). در برابر آن «فرایند دومین» (Secondary Process) قرار دارد: تفکر منطقی، زمان‌مند و مطابق واقعیت.

سرکوب و جبرگرایی روانی

«سرکوب» (Repression) را فروید سنگ بنای روانکاوی می‌خواند: راندن امیال، خاطره‌ها یا تصورهای ناپذیرفتنی به بیرون از آگاهی. سرکوب نابود کردن نیست؛ محتوا زنده می‌ماند و از راه‌های منحرف بازمی‌گردد. اصل دیگر **جبرگرایی روانی** است: هیچ رویداد روانی تصادفی نیست و پشت هر لغزش، فراموشی یا رؤیا علتی هست، حتی اگر نادیده بماند.

شواهدی که فروید به آنها استناد می‌کرد

- **رؤیا:** محتوایی که بیدار نمی‌توانیم بپذیریم، در خواب با پوشش ظاهر می‌شود.
- **لغزش و فراموشی:** خطاهای ظاهراً بی‌معنا که نیتی دیگر را نشان می‌دهند.
- **علامت:** معنای نمادین علائم هیستریک و وسواسی.
- **هیپنوتیزم:** کسی که فرمان پس‌هیپنوتیزمی را اجرا می‌کند و دلیلش را نمی‌داند.

ارزیابی امروز

تأییدشده: پردازش ناآگاهانه واقعیت علمی است؛ حافظهٔ ضمنی، پیش‌انگیزی (priming)، رفتار خودکار و ارزیابی هیجانی پیش از آگاهی، همه در آزمایش‌ها نشان داده شده‌اند. **رد یا مناقشه‌برانگیز:** «ناخودآگاه شناختی» مدرن چیزی بسیار خنثی‌تر از دیگ جوشان امیال جنسی و پرخاشگرانه است. مفهوم «خاطرهٔ سرکوب‌شدهٔ بازیافتنی» نیز در دههٔ ۱۹۹۰ به‌شدت نقد شد، چون حافظه بازسازی‌پذیر است و القا می‌پذیرد.

۰۳

ساختار روان: نهاد، من و فرامن

مدل مکان‌نگارانه نمی‌توانست توضیح دهد چرا بخشی از وجدان و بخشی از «من» نیز ناخودآگاه‌اند. فروید در ۱۹۲۳ نقشه را عوض کرد: روان یک میدان کشمکش میان سه کارگزار است.

نهاد

Id · Es

مخزن سائق‌ها. بی‌منطق، بی‌زمان، بی‌اخلاق. تابع اصل لذت: تخلیهٔ فوری تنش.

من

Ego · Ich

کارگزار واقعیت. برنامه‌ریزی، تأخیر در ارضا، آزمون واقعیت. تابع اصل واقعیت.

فرامن

Superego · Über-Ich

وجدان و آرمان‌های درونی‌شده از والدین و جامعه. با احساس گناه تنبیه می‌کند.

نهاد

نهاد کهن‌ترین بخش روان و منبع انرژی آن است. خواست‌هایش در لحظه ارضا می‌شوند یا فشار می‌آورند. نهاد نمی‌داند «نه» چیست و نمی‌تواند صبر کند؛ نوزاد گرسنه تقریباً تماماً نهاد است. بخش بزرگی از آن ناخودآگاه است و فرایند نخستین بر آن حاکم است.

من

«من» از نهاد در تماس با واقعیت جدا می‌شود. کارش وساطت است: میان خواسته‌های نهاد، ممنوعیت‌های فرامن و محدودیت‌های جهان بیرون. فروید می‌گفت «من» خدمتکار سه ارباب است و از سه سو تهدید می‌شود؛ تمثیل او سوارکاری است که نیروی اسب را هدایت می‌کند و گاه ناچار است همان‌جایی برود که اسب می‌خواهد. بخش مهمی از کار «من» ناخودآگاه است، از جمله سازوکارهای دفاعی‌اش.

فرامن

فرامن از درونی‌سازی اقتدار والدین پدید می‌آید و با حل عقدهٔ ادیپ (فصل ۶) شکل می‌گیرد. دو سویه دارد: وجدان که منع و تنبیه می‌کند و من آرمانی که الگو می‌سازد. فرامن می‌تواند بسیار سخت‌گیرتر از والدین واقعی باشد؛ احساس گناه ناخودآگاه و خودسرزنشی بیمارگون از همین‌جا می‌آید.

«آنجا که نهاد بود، من باید باشد.»

فروید، درس‌گفتارهای مقدماتی جدید، ۱۹۳۳

این جمله هدف درمان را خلاصه می‌کند: نه نابودی سائق‌ها و نه رها کردن‌شان، بلکه گسترش قلمرو آگاهی و انتخاب. روان سالم در این مدل کشمکش‌نداشتن نیست؛ «من»ی است که توان وساطت دارد و انعطاف‌پذیر است. نشانه‌ها و رؤیاها «سازش‌های میان‌شان» هستند.

ارزیابی امروز

مدل ساختاری را اکنون عمدتاً استعاره می‌دانند، نه سه موجود واقعی در مغز. اما شکلی از همین تقسیم‌بندی در پژوهش‌های امروز دیده می‌شود: نظریه‌های دوفرایندی تصمیم (سیستم ۱ و ۲)، کنش اجرایی لوب پیشانی، و احساس‌های اخلاقی مانند گناه و شرم. روانکاوان معاصر خود این مدل را به‌عنوان نقشه‌ای بالینی به کار می‌برند.

۰۴

غریزه‌ها: لیبیدو، اروس و سائق مرگ

نیروی محرک روان از نگاه فروید «سائق» است: فشاری که از بدن برمی‌خیزد و روان را به کار وامی‌دارد.

این نظریه دو بار دگرگون شد، اما پرسش یکی ماند: انسان بر پایهٔ چه کشمکشی ساخته شده است؟

واژهٔ آلمانی Trieb در ترجمهٔ انگلیسی قدیمی «غریزه» (instinct) شد، اما «سائق» (drive) دقیق‌تر است، چون سائق برخلاف غریزهٔ حیوانی قالب رفتاری ثابت ندارد. فروید در «سائق‌ها و دگرگونی‌های‌شان» (۱۹۱۵) چهار ویژگی برایش برشمرد: **سرچشمه** (یک نیاز بدنی)، **فشار** (شدت)، **هدف** (کاهش تنش) و **ابژه** (چیزی که با آن ارضا می‌شود؛ ابژه در سائق تصادفی و قابل تعویض است).

دوگانهٔ نخست: جنسیت در برابر خودنگهداری (تا ۱۹۲۰)

در الگوی اول، دو دسته سائق در برابر هم‌اند: سائق‌های جنسی و سائق‌های «من» (خودنگهداری مانند گرسنگی). انرژی سائق جنسی را فروید «لیبیدو» (Libido) نامید. «جنسی» در زبان او معنایی بسیار گسترده‌تر از آمیزش دارد: هر لذتی که از ناحیه‌های بدن (دهان، مقعد، اندام جنسی) و از ارتباط با دیگران برمی‌خیزد. «سه رساله دربارهٔ نظریهٔ جنسیت» (۱۹۰۵) سه ادعای تکان‌دهنده داشت: جنسیت از نوزادی آغاز می‌شود؛ کودک «چندشکل منحرف» (polymorphous perverse) است؛ و ابژهٔ میل ذاتاً ثابت نیست.

دوگانهٔ دوم: اروس در برابر سائق مرگ (۱۹۲۰ به بعد)

در «فراسوی اصل لذت» فروید به پدیده‌هایی رسید که با اصل لذت جور درنمی‌آمد: کابوس‌های تکراری سربازان جنگ، و بازی نوه‌اش با قرقره («رفت – آمد») که کودک غیبت مادر را تکرار می‌کرد. از اینجا «اجبار به تکرار» را مطرح کرد: گرایش به بازآفرینی تجربه‌های دردناک. توضیح او این بود که سائقی عمیق‌تر هست که می‌خواهد موجود زنده را به حالت بی‌جان پیشین برگرداند.

- **اروس (Eros، سائق‌های زندگی):** پیوند دادن، حفظ، ساختن؛ شامل میل جنسی و خودنگهداری.
- **سائق مرگ (Todestrieb):** گرایش به تخریب و بازگشت به صفر؛ وقتی به بیرون برگردد پرخاشگری است، وقتی به درون، خودتخریبی.

نکته: واژهٔ «تاناتوس» را فروید خودش به‌ندرت به کار برد و شاگردانش رواجش دادند.

ارزیابی امروز

مفهوم انرژی لیبیدویی قابل اندازه‌گیری نیست و علوم اعصاب آن را کنار گذاشته است. سائق مرگ حتی میان روانکاوان پذیرفته‌ترین بخش نظریه نیست و بسیاری آن را «بیولوژی نمادین» می‌دانند. در مقابل، اجبار به تکرار در پژوهش‌های تروما (PTSD) به شکلی مستقل تأیید شده است؛ و جنسیت به‌عنوان موضوع مشروع علمی، میراث ماندگار این بخش است.

۰۵

رشد روانی‌ـجنسی

فروید می‌گفت شخصیت بزرگسال محصول چند سال نخست زندگی است. کودک از مراحلی می‌گذرد که در هر یک، کانون لذت و کشمکش اصلی متفاوت است؛ ناکامی یا افراط در هر مرحله، ردی ماندگار بر شخصیت می‌گذارد.

مرحله	سن تقریبی	کانون لذت	کشمکش محوری و ردّ احتمالی در بزرگسالی
دهانی Oral	۰ تا ۱٫۵ سال	دهان، مکیدن، تغذیه	وابستگی و اعتماد؛ از شیر گرفتن. ردّ: وابستگی شدید، پرخوری یا سیگار، یا برعکس بدبینی و گزندگی.
مقعدی Anal	۱٫۵ تا ۳ سال	دفع و نگه‌داشتن	کنترل و استقلال؛ آموزش دستشویی. ردّ: وسواس نظم، خست و لجاجت، یا برعکس آشفتگی و ولخرجی.
آلتی Phallic	۳ تا ۶ سال	اندام جنسی، کنجکاوی	عقدهٔ ادیپ و ترس از اخته‌شدن؛ شکل‌گیری فرامن و هویت جنسی.
نهفتگی Latency	۶ تا بلوغ	سائق‌ها فروکش می‌کنند	انرژی به یادگیری، دوستی و بازی والایش می‌یابد.
تناسلی Genital	از بلوغ	ارتباط جنسی بالغ	عشق ابژه‌ای و کار؛ توان مهر و تولید.

تثبیت و پسروی

تثبیت (Fixation) یعنی بخشی از لیبیدو در مرحله‌ای می‌ماند، چون ارضا در آن بیش از حد یا کمتر از حد بوده است. **پسروی** (Regression) یعنی در برابر فشار، فرد به شیوه‌ای از ارضا یا رفتار بازمی‌گردد که به مرحلهٔ زودتر تعلق دارد. بزرگسالی که زیر استرس ناخن می‌جود یا بی‌اختیار می‌خورد، نمونه‌ای رایج است.

ارزیابی امروز

توالی ثابت مراحل و ارتباط مستقیم‌شان با تیپ‌های شخصیتی پشتیبانی تجربی ندارد. آنچه ماند، اصل کلی است: تجربهٔ رابطه‌ای سال‌های نخست در شکل‌گیری شخصیت و الگوهای هیجانی اهمیت دارد. نظریهٔ دلبستگی (Bowlby) و روان‌شناسی رشد، همین اصل را با روش علمی پی گرفتند و از چارچوب لیبیدو فاصله گرفتند.

۰۶
عقدهٔ ادیپ

اگر روانکاوی یک «ایدهٔ شاخص» داشته باشد، همین است: خانواده نخستین صحنهٔ عشق، رقابت و ممنوعیت است، و آنچه در آن می‌گذرد معماری درونی بزرگسال را می‌سازد.

فروید نخستین‌بار در نامه‌ای به فلیس (۱۸۹۷) از این ایده سخن گفت و آن را در «تعبیر رؤیا» (۱۹۰۰) آورد؛ اصطلاح «عقدهٔ ادیپ» از ۱۹۱۰ در آثارش آمد. نامش را از نمایشنامهٔ «شاه ادیپ» سوفوکل گرفت: مردی که ندانسته پدرش را می‌کشد و با مادرش ازدواج می‌کند. فروید همین ساختار را در «هملت» شکسپیر هم دید: شاهزاده‌ای که از انتقام‌گرفتن از مردی که آرزوی ناخودآگاه خودش را تحقق داده، ناتوان است.

روایت کلاسیک برای پسر

در مرحلهٔ آلتی پسر مادر را به‌عنوان ابژهٔ عشق می‌خواهد و پدر را رقیب می‌بیند. اما پدر قدرتمند است و پسر می‌ترسد انتقام بگیرد؛ این ترس در روانکاوی کلاسیک «اضطراب اخته‌شدگی» نام دارد. پسر برای فرار از این ترس، میل به مادر را سرکوب و با پدر همانندسازی می‌کند. حاصل کار تشکیل فرامن است: قوانین پدر اکنون در درون او حکم می‌رانند.

دختر و مسئلهٔ زنانگی

فروید برای دختر مسیری پیچیده‌تر و به‌نظر خودش مبهم‌تر ترسیم کرد: کشف نبود آلت، «حسرت آلت» (penis envy)، روی‌گرداندن از مادر و رو آوردن به پدر. او در ۱۹۲۶ اعتراف کرد زندگی جنسی زن برای روان‌شناسی هنوز «قارهٔ تاریک» است. اصطلاح «عقدهٔ الکترا» از یونگ است و فروید آن را نپذیرفت. او همچنین به ادیپ کامل باور داشت: هر کودک ترکیبی از میل به هر دو والد دارد (دوجنس‌خواهی بنیادین).

نمونهٔ بالینی: هانس کوچک

در تحلیل «هانس کوچک» (۱۹۰۹)، پسربچهٔ پنج‌ساله‌ای که از اسب می‌ترسید، فروید ترس را جابه‌جایی ترس از پدر دانست. این تنها گزارش بالینی منتشرشدهٔ فروید از یک کودک است، و او عمدتاً از راه پدر کودک، که از شاگردانش بود، پیش رفت.

ارزیابی امروز

ادعای عمومیت ادیپ در همهٔ فرهنگ‌ها را مردم‌شناسانی چون مالینوفسکی (ترویبراند) به چالش کشیدند. روانکاوی فمینیستی و روان‌شناسان زن (هورنای، بعدها میچل) فرض «حسرت آلت» را رد یا بازتعبیر کردند. اما چیزی از آن ماند: اهمیت مثلث خانوادگی، رقابت و همانندسازی با والد، و فهم اینکه اخلاق درونی کودک از ارتباط با اقتدار می‌آید.

۰۷

اضطراب و سازوکارهای دفاعی

اگر روان میدان کشمکش است، باید سازوکارهایی داشته باشد که فشار آن را مهار کند. فروید آنها را «دفاع» نامید: راه‌هایی که «من» برای دور نگه‌داشتن اضطراب و محتوای ناپذیرفتنی به کار می‌برد.

نظریهٔ اضطراب

در الگوی نخست، فروید اضطراب را لیبیدوی ارضانشده می‌دانست که به اضطراب بدل می‌شود. در «بازدارنده‌ها، نشانه‌ها و اضطراب» (۱۹۲۶) این رابطه را وارونه کرد: اضطراب **علامت هشدار** «من» است که خطر را اعلام می‌کند و دفاع را به کار می‌اندازد. خطرهای بنیادین از دید او چهار موقعیت‌اند: از دست‌رفتن ابژه (مثلاً مادر)، از دست‌رفتن عشق او، ترس از اخته‌شدن، و ترس از تنبیه فرامن. فروید سه نوع اضطراب را تفکیک کرد: **واقعی** (تهدید بیرونی)، **روان‌رنجورانه** (ترس از سائق‌های خود) و **اخلاقی** (گناه و شرم در برابر فرامن).

سازوکارهای دفاعی

خود فروید برخی دفاع‌ها را توصیف کرد، اما این آنا فروید بود که در «من و سازوکارهای دفاعی» (۱۹۳۶) آنها را نظام‌مند ساخت. فهرست زیر مهم‌ترین‌هاست.

دفاع	سازوکار	نمونه
سرکوب Repression	راندن ناآگاهانهٔ محتوای دردناک به ناخودآگاه	فراموش‌کردن یک خاطرهٔ آسیب‌زا
انکار Denial	نپذیرفتن واقعیتی که تهدیدکننده است	بیماری که تشخیص را باور نمی‌کند
فرافکنی Projection	نسبت‌دادن احساس یا میل ناپذیرفتنی خود به دیگری	«او از من متنفر است» به‌جای «من از او متنفرم»
جابه‌جایی Displacement	انتقال هیجان از هدف اصلی به هدف بی‌خطرتر	خشم از رئیس، خالی‌شدن بر سر خانواده
واکنش‌سازی Reaction formation	تبدیل میل نامطلوب به ضد آن	مهربانی افراطی نسبت به کسی که از او بیزاری

پسروی Regression	بازگشت به الگوهای رفتاری مرحلهٔ پیشین رشد	بزرگسالی که زیر فشار مثل کودک رفتار می‌کند
عقلانی‌سازی Rationalization	ساختن توجیه منطقی برای انگیزهٔ واقعی ناپذیرفتنی	«این کار را برای خیر او کردم»
فکری‌سازی Intellectualization	پرداختن به جنبهٔ نظری برای دوری از هیجان	تحلیل سرد بیماری خود به‌جای احساس ترس
ابطال Undoing	عملی نمادین که گویی کاری را خنثی می‌کند	شست‌وشوی آیینی پس از فکر «ناپاک»
والایش Sublimation	تبدیل سائق به فعالیتی که اجتماع می‌پذیرد	پرخاشگری که در ورزش یا هنر تخلیه می‌شود

فروید والایش را تنها دفاعی می‌دید که هم سائق را ارضا می‌کند و هم تمدن را می‌سازد. بعدها جرج ویلانت (George Vaillant) دفاع‌ها را از «نابالغ» (انکار، فرافکنی) تا «بالغ» (والایش، شوخ‌طبعی، نوع‌دوستی) رتبه‌بندی کرد.

ارزیابی امروز

مفهوم دفاع از موفق‌ترین بخش‌های روانکاوی است: در روان‌شناسی بالینی، پژوهش مقابله و تنظیم هیجان، بدون آنکه ریشه در لیبیدو داشته باشد، به‌شکل مستقل به کار می‌رود. دفاع‌هایی مانند انکار، فرافکنی و عقلانی‌سازی در پژوهش‌های تجربی هم بررسی شده‌اند؛ والایش تنها دفاعی است که آزمودنش دشوار مانده است.

۰۸

رؤیا: راه شاهانه به ناخودآگاه

«تعبیر رؤیا» را فروید مهم‌ترین کتاب خود می‌دانست. ادعای کتاب ساده و جسورانه بود: رؤیا بی‌معنا نیست؛ تحقق پوشیدهٔ یک آرزوی سرکوب‌شده است، و تعبیرش راه شاهانه به ناخودآگاه.

پیش از فروید رؤیا را یا پیام الهی می‌دانستند یا پژواک بی‌نظم فعالیت مغز. فروید سومین راه را رفت: رؤیا معنایی دارد که با تحلیل کشف می‌شود. نخستین رؤیایی که او به‌تفصیل تحلیل کرد، «رؤیای تزریق به ایرما» (جولای ۱۸۹۵) بود، رؤیایی دربارهٔ بیماری که درمانش به نتیجه نرسیده بود؛ فروید در آن تحلیل دریافت رؤیا مسئولیت او را به دیگران نسبت می‌دهد و آرزوی تبرئه را برآورده می‌کند.

دو لایهٔ رؤیا

محتوای آشکار (manifest content) همان است که هنگام بیداری به یاد می‌آوریم؛ **محتوای نهفته** (latent content) آرزو و اندیشه‌های پنهانی است که رؤیا پوشانده است. رؤیا در خواب از سانسور رها نمی‌شود، فقط ضعیف‌تر می‌شود؛ پس آرزو باید «تغییر چهره» بدهد. مجموعهٔ کارهایی که این تغییر را می‌سازند «کار رؤیا» (dream-work) نام دارد.

سازوکار	کار آن
تراکم Condensation	چند فکر، شخص یا موقعیت در یک تصویر فشرده می‌شوند؛ شخصیتی که در رؤیا هست، ترکیب چند آدم واقعی است.
جابه‌جایی Displacement	بار هیجانی از موضوع اصلی به جزئیات بی‌اهمیت منتقل می‌شود؛ مرکز رؤیا با مرکز واقعی آن فرق دارد.
نمایش‌پذیری Representation	اندیشه‌های انتزاعی به تصویر دیداری ترجمه می‌شوند.
بازنگری دومین Secondary revision	ذهن بیدار در لحظهٔ یادآوری، رؤیا را منسجم‌تر و داستانی‌تر می‌کند.

فروید دو چیز دیگر را هم تأکید می‌کرد. اول، «بازماندهٔ روز» (day residue): ماده‌ای از تجربهٔ روز پیش که آرزوی قدیمی‌تر به آن سوار می‌شود. دوم، نمادها: فروید نمادهای عام (مثلاً اشیای کشیده، فضاهای محصور) را می‌پذیرفت، اما اصرار داشت تعبیر درست بدون تداعی‌های خود رؤیابین ممکن نیست و «فرهنگ لغت رؤیا» ساختن کار نادرستی است.

مثال ساده

کودکی که شب پیش تشنه خوابیده، در رؤیا می‌بیند آب می‌نوشد؛ رؤیا هم خواب او را حفظ می‌کند و هم آرزویش را برآورده می‌سازد. فروید این مثال را مدل رؤیاهای کودکانه می‌دانست، چون در آنها تحریف کمی هست. رؤیاهای بزرگسالان چون آرزوهای ناپذیرفتنی‌تری دارند، تحریف بیشتری می‌طلبند.

ارزیابی امروز

ادعای «هر رؤیا تحقق آرزوست» را شواهد تأیید نمی‌کند؛ کابوس‌ها و رؤیاهای ترومایی نقض‌اند، و فروید خودش در ۱۹۲۰ به این نکته اذعان کرد. کشف خواب (۱۹۵۳) REM و نظریهٔ فعال‌سازی ـ ترکیب (هابسون و مک‌کارلی) رؤیا را با فعالیت مغز ساقه توضیح دادند. با این حال رؤیا بی‌معنا هم نیست: پژوهش‌ها نشان می‌دهند محتوای رؤیا با دغدغه‌های هیجانی بیداری پیوند دارد، و مارک سولمز استدلال کرده رؤیابینی فقط به REM وابسته نیست و به مدارهای انگیزشی پیشانی هم متکی است.

۰۹

روان‌رنجوری، هیستری و علامت

علامت روانی در نگاه فروید حرفی است که به زبان نیامده: بیان نمادین یک کشمکش ناخودآگاه که راه دیگری برای ابراز نداشته است.

روان‌رنجوری (neurosis) در این نظریه **سازش** است: علامت در عین حال ارضای پنهان یک میل سرکوب‌شده و تنبیه آن است. بیماری که دستش بی‌حس شده، دستی را فلج کرده که نباید حرکت می‌کرد. فروید سه خانوادهٔ بزرگ بالینی را بر همین مبنا شرح داد.

هیستری و تبدیل

در هیستری، تعارض روانی به علامت جسمی «تبدیل» (conversion) می‌شود: فلج، کوری، سرفه، بی‌صدایی بدون آسیب عضوی. تحلیل «دورا» (۱۹۰۵، نام واقعی ایدا بائر) یکی از معروف‌ترین پرونده‌های او است؛ بیمار پس از یازده هفته درمان را قطع کرد و فروید خودش در آن نوشته به ضعف کار در برخورد با انتقال اشاره دارد. منتقدان بعدی گفته‌اند فروید تفسیر خود را بر او تحمیل کرد.

وسواس، فوبیا و پارانویا

- **اختلال وسواسی (Rat Man، ۱۹۰۹):** افکار و آیین‌های اجباری؛ تعارض میان عشق و نفرت نسبت به یک شخص.
- **فوبیا (هانس کوچک):** جابه‌جایی اضطراب به ابژه‌ای بیرونی که می‌توان از آن دوری کرد.
- **پارانویا (شرِبر، ۱۹۱۱):** فروید فقط از روی خاطرات نوشتهٔ بیمار تحلیل کرد؛ فرافکنی میل همجنس‌خواهانهٔ سرکوب‌شده را مبنای پارانویا دانست.
- **مرد گرگی (Wolf Man، ۱۹۱۸):** تحلیل طولانی یک جوان روسی، با نقش خاطرهٔ «صحنهٔ آغازین».

نظریهٔ اغوا و کنار گذاشتنش

در ۱۸۹۶ فروید ادعا کرد ریشهٔ هیستری، آزار جنسی واقعی در کودکی است («نظریهٔ اغوا»). در نامه‌ای به فلیس در سپتامبر ۱۸۹۷ نوشت دیگر به «روان‌رنجوری‌هاش» باور ندارد: از جمله به این دلیل که باورپذیر نبود این‌همه پدر آزارگر باشند، و در ناخودآگاه میان خاطره و خیال تمایزی نمی‌دید. از آن پس، نقش **فانتزی** و واقعیت روانی را برجسته کرد. این تغییر از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات تاریخ روانکاوی است: برخی (مانند جفری ماسون) آن را فرار از پذیرش واقعیت آزار دانسته‌اند؛ برخی دیگر آن را گذار به نظریه‌ای دربارهٔ تخیل می‌دانند که انکار آزار نبود. مورخان هنوز بر سر آن توافق ندارند.

روان‌رنجوری، روان‌پریشی و تروما

در «روان‌رنجوری و روان‌پریشی» (۱۹۲۴) فروید تمایز ساخت: در روان‌رنجوری تعارض میان «من» و نهاد است، و در روان‌پریشی میان «من» و واقعیت بیرون. پس از جنگ جهانی اول هم موج «روان‌رنجوری ترومایی» او را متقاعد کرد که ضربهٔ ترومایی می‌تواند ظرفیت «من» برای مهار برانگیختگی را درهم بشکند؛ نتیجه، همان اجبار به تکرار است.

ارزیابی امروز

«اختلال نشانگان عصبی کارکردی» (FND) امروز رسماً شناخته می‌شود و وجود علائم جسمی با ریشهٔ روانی تأیید شده است، هرچند سازوکار پیشنهادی فروید ثابت نشد. توصیف‌های فروید از وسواس و فوبیا بالینی‌اند، اما تبیین علّی او دربارهٔ آنها (جابه‌جایی سائق‌های ادیپی) شواهد تجربی کافی ندارد. پرونده‌های او به‌شدت گزینشی هستند و نتایج درمان کمتر از آنچه او می‌نوشت موفق بود.

۱۰

روانکاوی به‌مثابه روش درمان

فروید می‌گفت واقع‌بینانه‌ترین هدف درمان، تبدیل «بدبختی هیستریک» به «ناخشنودی معمولی» است. او وعدهٔ خوشبختی نمی‌داد؛ وعدهٔ توانایی می‌داد.

از هیپنوتیزم تا تداعی آزاد

روش در طول زمان تکامل یافت: نخست هیپنوتیزم و تخلیهٔ هیجانی (بروير) و سرانجام **تداعی آزاد** (free association). فروید می‌گفت بیمارش «اِمّی فون ان» از او خواست مدام قطع‌اش نکند؛ این‌گونه او به ارزش گفتن بی‌مانع پی برد. «قاعدهٔ بنیادین» روانکاوی این است: هر چه به ذهن می‌رسد بگو، حتی اگر بی‌ربط، شرم‌آور یا بی‌اهمیت به نظر برسد.

چارچوب

در شکل کلاسیک، بیمار روی کاناپه دراز می‌کشد و تحلیل‌گر پشت سر او می‌نشیند و دیده نمی‌شود؛ جلسات چندبار در هفته و چندین سال ادامه دارد. تحلیل‌گر با «توجه شناور برابر» (evenly suspended attention) گوش می‌دهد، بی‌طرف می‌ماند و از ارضای نیازهای بیمار می‌پرهیزد.

فرایندهای کلیدی

- **مقاومت** (Resistance)**:** هر آنچه بیمار ناآگاهانه می‌کند تا مانع رسیدن به محتوای سرکوب‌شده شود: سکوت، فراموشی، دیر آمدن.
- **انتقال** (Transference)**:** بیمار احساسات و انتظارات نسبت به افراد مهم گذشته (والدین) را بر تحلیل‌گر می‌افکند. فروید ابتدا آن را مانع می‌دید و بعد ابزار اصلی درمان؛ چون الگوی قدیمی را زنده و قابل بررسی می‌کند.
- **انتقال متقابل** (Countertransference)**:** واکنش‌های هیجانی خود تحلیل‌گر به بیمار.
- **تفسیر** (Interpretation)**:** ارائهٔ معنای ناخودآگاه آنچه بیمار می‌گوید یا می‌کند، در لحظهٔ مناسب.
- **کار گذر** (Working-through)**:** تکرار و بازبینی طولانی بینش، تا از شناخت ذهنی به تغییر واقعی برسد.

او در «تحلیل پایان‌پذیر و پایان‌ناپذیر» (۱۹۳۷) صادقانه پذیرفت که تحلیل ممکن است هرگز کامل نشود.

ارزیابی امروز

پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهند درمان‌های روان‌پویشی کوتاه‌مدت اثر متوسط تا قابل‌توجه دارند (شدلر ۲۰۱۰)، در حالی که شواهد برای روانکاوی کلاسیک بلندمدت محدودتر و محل نزاع است. شناخت‌درمانی و رفتاری در تعداد کارآزمایی‌ها پیش است، اما بسیاری از درمان‌گران در هر مکتب از مفهوم انتقال و اهمیت رابطهٔ درمانی بهره می‌برند.

۱۱

زندگی روزمره، شوخی و هنر

فروید نظریه‌اش را فقط به بیمارستان و بیماران محدود نکرد. استدلالش این بود که سازوکارهای روان‌رنجور و روان سالم یکی‌اند؛ تفاوت در شدت است. پس ناخودآگاه را باید در لغزش‌های هر روز، در لطیفه و در اثر هنری هم جست.

لغزش‌ها

در «روان‌آسیب‌شناسی زندگی روزمره» (۱۹۰۱) فروید خطاهای کوچک را بررسی کرد: لغزش زبان («لغزش فرویدی»)، فراموشی نام‌ها، گم‌کردن اشیا، خطای خواندن، کارهای ناخواسته. استدلالش این بود که این خطاها زمانی رخ می‌دهند که نیت آگاه با نیتی سرکوب‌شده برخورد می‌کند. نمونهٔ مشهور او، فراموشی نام نقاش «سینیورلی» (Signorelli) در گفت‌وگو دربارهٔ مرگ و جنسیت است، که او آن را به سرکوب موضوعی ناخوشایند ربط داد.

شوخی

«لطیفه و رابطهٔ آن با ناخودآگاه» (۱۹۰۵) شوخی را حامل همان سازوکارهای رؤیا (تراکم و جابه‌جایی) می‌داند. خنده از صرفه‌جویی در انرژی روانی می‌آید: انرژی‌ای که برای سرکوب یک تکانه آماده شده بود، ناگهان آزاد می‌شود. شوخی‌های خصمانه و شهوانی «تکانه‌ای ممنوع» را با پوشش اجتماعی بیرون می‌دهند. فروید در مقالهٔ «شوخ‌طبعی» (۱۹۲۷) آن را مهربان‌ترین چهرهٔ فرامن می‌دانست.

هنر و خلاقیت

در «نویسندگان خلاق و رؤیاپردازی» (۱۹۰۸) فروید هنرمند را همان کودکی می‌دید که بازی‌اش را رها نکرده و به خیال‌بافی تبدیل کرده است؛ اثر هنری خیال شخصی است که چنان پرداخته شده که دیگران هم از آن لذت می‌برند. او تحلیل‌هایی از «لئوناردو داوینچی» (۱۹۱۰)، «موسای میکل‌آنژ» (۱۹۱۴)، «داستایفسکی و پدرکشی» (۱۹۲۸) و مقالهٔ «امر نامأنوس» (Das Unheimliche، ۱۹۱۹) نوشت. همین مسیر به روانکاوی ادبی و نقد هنری راه برد.

ارزیابی امروز

روان‌شناسی زبان نشان داده بیشتر لغزش‌ها از رقابت میان برنامه‌های گفتاری می‌آیند (بارس، موتلی) و نیازی به انگیزهٔ پنهان ندارند؛ با این همه آزمایش‌های موتلی نشان دادند محرک‌های جنسی یا اضطرابی می‌توانند احتمال لغزش‌های مرتبط را بالا ببرند. تحلیل‌های هنری فروید از جمله «لئوناردو» اکنون عمدتاً به‌عنوان کار تخیلی نقد می‌شوند، اما چارچوب «اثر هنری به‌مثابه فانتزی پرداخته» فکر ماندگاری در نقد ادبی و مطالعات فرهنگی شد.

۱۲

فرهنگ، دین و تمدن

در آثار دورهٔ پایانی فروید پرسش از فرد به نوع بشر منتقل می‌شود: اگر انسان سائق‌هایی دارد که با زندگی جمعی ناسازگارند، تمدن بر چه بهایی ساخته شده است؟

توتم و تابو (۱۹۱۳)

فروید فرضیهٔ «گلهٔ نخستین» را مطرح کرد: پسران گروهی که پدر مستبد آنها را از زنان محروم کرده بود، او را کشتند و خوردند؛ سپس گناه، آنها را به پرستش جانشین پدر (توتم) و منع زنای با محارم (تابو) کشاند. این قصه هیچ پایهٔ مردم‌شناختی ندارد و مردم‌شناسان (کروبر و دیگران) آن را رد کردند. خود فروید آن را حقیقت تاریخی می‌دانست؛ امروز بیشتر به‌عنوان **اسطورهٔ نظری** خوانده می‌شود، روایتی دربارهٔ منشأ گناه و اقتدار.

آیندهٔ یک پندار (۱۹۲۷)

دین از نظر فروید «پندار» (illusion) است: باوری که از آرزو می‌آید، نه از شواهد. ریشه‌اش درماندگی کودکی و اشتیاق به پدری حامی است که در سطح کیهانی بازسازی می‌شود. او میان «پندار» و «توهم» فرق می‌گذاشت: پندار لزوماً کاذب نیست، اما انگیزهٔ باور به آن آرزوست. امیدش به آموزش و عقل بود: «صدای عقل آرام است، اما تا شنیده نشود آرام نمی‌گیرد.»

ناخشنودی‌های تمدن (۱۹۳۰)

این کتاب فشردهٔ فلسفهٔ اجتماعی فروید است. استدلال اصلی: تمدن بر **وانهادن سائق‌ها** بنا شده است. جامعه برای بقا باید پرخاشگری و میل جنسی را مهار کند؛ این مهار به‌صورت گناه در درون فرد می‌نشیند (فرامن، پرخاشگری را به خود برمی‌گرداند). نتیجه: هرچه تمدن بیشتر پیشرفت کند، احساس گناه و ناخشنودی بیشتر می‌شود. فروید سه سرچشمهٔ رنج می‌شمرد: بدن ناتوان، جهان بیرون و روابط با دیگران. و «خوشبختی» را برنامهٔ اصل لذت می‌داند که واقعیت هرگز تأمین نمی‌کند. راه‌های مقابله: انزوا، مستی و مواد، والایش، پندار و عشق؛ هیچ‌کدام کامل نیست.

توده، رهبر و جنگ

در «روان‌شناسی توده و تحلیل من» (۱۹۲۱) فروید توضیح داد افراد در توده «من آرمانی» خود را با رهبر جایگزین می‌کنند و از راه همانندسازی با یکدیگر پیوند می‌خورند؛ تحلیلی که قبل از ظهور فاشیسم، سازوکار شیفتگی به رهبر را آشکار می‌کرد. در نامهٔ «چرا جنگ؟» (۱۹۳۲) به انیشتین نوشت امید او رشد فرهنگ و پیوندهای هیجانی میان انسان‌هاست. «موسی و یکتاپرستی» (۱۹۳۹) نیز دین یهود را با ادعای مصری‌بودن موسی بازخوانی می‌کند؛ نظریه‌ای بی‌اتکا به شواهد و بسیار مناقشه‌انگیز.

ارزیابی امروز

در سطح علمی، آثار فرهنگی فروید ضعیف‌ترین بخش مجموعه‌اند: فاقد پشتوانهٔ مردم‌شناختی، و گاه از مشاهدهٔ محدود نتیجهٔ کلی می‌گیرند. اما از جنبهٔ فکری، پیامدشان بزرگ بود: مارکوزه و رایش و فروم از آنها برای نقد جامعه استفاده کردند، و مفاهیم گناه، دوسوگرایی، همانندسازی گروهی و بهای سرکوب اجتماعی بخشی از زبان علوم انسانی شدند.

۱۳

سوگ، مالیخولیا و خودشیفتگی

فروید در دو مقالهٔ کوتاه دربارهٔ از دست دادن و دربارهٔ عشق به خود، چارچوبی ساخت که بیش از یک قرن بعد هنوز زیربنای فهم روان‌شناختی افسردگی و شخصیت است.

سوگ و مالیخولیا (۱۹۱۷)

در **سوگ** فرد پس از ازدست‌دادن یک ابژهٔ دوست‌داشتنی، به‌تدریج و با رنج، لیبیدو را از آن جدا می‌کند و دوباره آزاد می‌شود. این «کار سوگ» (grief work) آزمون واقعیت است: ابژه دیگر نیست. در **مالیخولیا** (که امروز آن را به افسردگی نزدیک می‌دانیم) فرد نه‌تنها غمگین است، بلکه عزت‌نفسش فرو می‌ریزد و خود را سرزنش می‌کند. تحلیل فروید: فرد با ابژهٔ ازدست‌رفته همانندسازی کرده و خشم دوسوگرایانه‌ای را که به او داشت علیه خودش برمی‌گرداند. جملهٔ مشهور او: «سایهٔ ابژه بر من افتاد.»

دربارهٔ خودشیفتگی (۱۹۱۴)

فروید دو نوع خودشیفتگی را تمایز داد: **اولیه** (حالت طبیعی نوزاد که لیبیدو را کامل متوجه خود می‌داند) و **ثانویه** (بازگشت لیبیدو از ابژه‌ها به خود). عزت‌نفس بزرگسال را وابسته به این می‌دانست که تا چه اندازه «من» با «من آرمانی» همخوان است و دوست داشته شدن. همچنین دو الگوی انتخاب ابژه را شناسایی کرد: **تکیه‌گاهی** (کسی را دوست می‌داریم که از ما مراقبت می‌کند) و **خودشیفته‌وار** (کسی را که شبیه خود ماست یا مایلیم باشیم).

ارزیابی امروز

این مقاله‌ها پایهٔ نظریهٔ دلبستگی و از دست‌دادن (بالبی)، روان‌شناسی خود (کوهوت) و نظریه‌های شناختی دربارهٔ خودانتقادی در افسردگی بودند. اما «کار سوگ» اکنون محل بحث است: پژوهش‌های استروبه و شات نشان می‌دهند همهٔ سوگواران نیازمند مواجههٔ پیوسته با اندوه نیستند و رفت‌وبرگشت میان مواجهه و گریز هم طبیعی است (مدل فرایند دوگانه).

۱۴

جانشینان و شاخه‌های روانکاوی

روانکاوی یک مکتب واحد نماند. هر شاخه بخشی از میراث فروید را برگزید و بخشی را رد کرد؛ نتیجه شبکه‌ای از نظریه‌هاست که امروز در بالین و فرهنگ زنده‌اند.

نام	جریان	اندیشهٔ محوری و فاصله با فروید
آلفرد آدلر Adler	روان‌شناسی فردی	انگیزهٔ اصلی «جبران حس حقارت» و «علاقهٔ اجتماعی» است، نه لیبیدو. ۱۹۱۱ جدا شد.
کارل گوستاو یونگ Jung	روان‌شناسی تحلیلی	لیبیدو انرژی عام روانی است؛ ناخودآگاه جمعی و کهن‌الگوها. ۱۹۱۳ جدا شد.
اتو رانک Rank	—	«ضربهٔ تولد» به‌عنوان اضطراب بنیادین؛ تأکید بر رابطهٔ مادر و نوزاد.
ویلهلم رایش Reich	تحلیل خصلت	سرکوب جنسی در بدن و ساختار اجتماعی تثبیت می‌شود؛ بعدها از جریان اصلی فاصله گرفت.
شاندور فرنتسی Ferenczi	—	درمان فعال‌تر و همدلانه‌تر، توجه به نقش تروما؛ پیشگام روان‌درمانی رابطه‌ای.
آنا فروید Anna Freud	روان‌شناسی من	نظام‌مندکردن دفاع‌ها و بنیان‌گذاری تحلیل کودک.
هاینتس هارتمان Hartmann	روان‌شناسی من	«حوزهٔ بی‌تعارض من»: ادراک، حافظه و تفکر رشد خود را دارند.
اریک اریکسون Erikson	روان‌شناسی من	هشت مرحلهٔ روانی‌ـاجتماعی در تمام عمر و مفهوم «بحران هویت».
ملانی کلاین Klein	روابط ابژه	ابژه‌های درونی از همان نوزادی؛ «وضعیت پارانوئید ـ اسکیزوئید» و «وضعیت افسرده‌وار».

دونالد وینیکات Winnicott	روابط ابژه	«مادر به‌قدر کافی خوب»، ابژهٔ انتقالی، خود حقیقی و خود کاذب.
جان بالبی Bowlby	نظریهٔ دلبستگی	پیوند با مراقب نیاز زیستی است، نه فرع بر سائق؛ پایهٔ پژوهش تجربی.
هاینتس کوهوت Kohut	روان‌شناسی خود	رشد «خود» به همدلی و آینه‌شدن مراقبان وابسته است.
سالیوان، هورنای، فروم	بین‌فردی و فرهنگی	جامعه و روابط، نه سائق‌های درونی، عامل اصلی شکل‌گیری روان‌رنجوری‌اند.
ژاک لاکان Lacan	روانکاوی ساختارگرا	«ناخودآگاه همچون زبان ساختار یافته است»؛ مرحلهٔ آینه؛ بازگشت به متن فروید.

۱۵

نقد، ارزیابی و میراث

فروید را نه می‌توان همچون کاشف قطعی ستود، نه همچون شارلاتان کنار گذاشت. ارزیابی دقیق او نیازمند جدا کردن سه چیز است: چه چیزی ماند، چه چیزی اصلاح شد، و چه چیزی رد شد.

انتقادهای اصلی

- **ابطال‌ناپذیری:** کارل پوپر (دههٔ ۱۹۳۰ تا ۶۰) استدلال کرد نظریه‌ای که هر رفتاری را توضیح می‌دهد، چیزی را پیش‌بینی نمی‌کند و علمی نیست. آدولف گرونبوم پاسخ داد روانکاوی ادعاهای آزمودنی دارد، اما شواهد بالینی‌اش آلوده به القا است.
- **روش:** پرونده‌ها گزینشی‌اند، نمونه کوچک و از یک طبقهٔ اجتماعی (بورژوای وین)، و داده‌ها در اتاق درمان و زیر تأثیر خود تحلیل‌گر گردآوری شده است. فردریک کروز و پژوهشگران دیگر حتی صحت گزارش‌های درمان را به چالش کشیده‌اند.
- **جنسیت و زنان:** نظریهٔ حسرت آلت و رشد زنانگی مردمحور است؛ هورنای از درون روانکاوی و بووار و میلت از بیرون آن را نقد کردند. جولیت میچل بعدها استدلال کرد فروید توصیفگر پدرسالاری بود، نه مدافع آن.
- **فرهنگی:** عمومی‌سازی یافته‌های محدود به کل بشر (توتم و تابو، ادیپ جهانی).

چه چیزی ماند؟

ماند	اصلاح شد	رد شد
پردازش ناآگاهانه؛ اهمیت تجربهٔ سال‌های اول؛ دفاع‌ها و مقابله؛ دوسوگرایی و کشمکش درونی؛ الگوهای انتقالی در روابط؛ ارزش گفت‌وگودرمانی؛ جنسیت به‌عنوان موضوع علمی.	نظریهٔ سائق ← نظریه‌های انگیزش و هیجان؛ مراحل ← دلبستگی و رشد؛ تحلیل بلندمدت ← روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت؛ رؤیا ← پردازش هیجانی.	لیبیدو به‌عنوان انرژی قابل‌اندازه‌گیری؛ ادیپ همگانی؛ حسرت آلت؛ سائق مرگ به‌عنوان بیولوژی؛ گلهٔ نخستین؛ هر رؤیا = آرزو.

میراث گسترده‌تر

واژه‌های «سرکوب»، «فرافکنی»، «عقدهٔ حقارت»، «لغزش فرویدی» و «روان‌رنجور» وارد زبان روزمره شدند. سوررئالیسم (برتون، دالی) و بخش بزرگی از ادبیات مدرن (جویس، مان، کافکا) با تصویر ناخودآگاه ساخته شد. هیچکاک در «طلسم‌شده» روانکاوی را روی پرده برد. ادوارد برنیز، خواهرزادهٔ فروید، با به‌کارگیری ایدهٔ انگیزه‌های پنهان، روابط عمومی و تبلیغات مدرن را بنیان گذاشت. در فلسفه، پل ریکور فروید را در کنار مارکس و نیچه یکی از «استادان سوءظن» نامید: اندیشمندانی که معتقدند آنچه آگاهی می‌گوید، کل حقیقت نیست.

فروید پرسش را عوض کرد: از «انسان چه می‌کند؟» به «چرا چنین می‌کند، و چه چیزی را از خودش پنهان می‌کند؟»

شاید ارزشمندترین میراث او خود نظریه‌ها نباشد، بلکه شیوهٔ نگریستن است: فرض کنیم رفتار، حتی خطا و علامت و رؤیا، معنایی دارد؛ بشنویم پیش از آنکه قضاوت کنیم؛ و اجازه دهیم انسان بیش از آنچه به‌نظر می‌رسد پیچیده باشد. حتی کسانی که نظریهٔ فروید را رد می‌کنند، از پرسش‌هایی استفاده می‌کنند که او باب کرد.

پیوست الف: گاهشمار

رویدادهای کلیدی زندگی و آثار فروید به ترتیب زمان.

۱۸۵۶	تولد در فرایبرگ موراویا (۶ مه).
۱۸۷۳	ورود به دانشکدهٔ پزشکی دانشگاه وین.
۱۸۸۱	دریافت دکترای پزشکی.
۸۶–۱۸۸۵	اقامت در پاریس نزد شارکو.
۱۸۸۶	گشودن مطب در وین و ازدواج با مارتا برنایس.
۱۸۹۵	انتشار «مطالعاتی دربارهٔ هیستری» با بروير؛ رؤیای ایرما.
۱۸۹۶	مرگ پدر؛ نخستین کاربرد اصطلاح «روانکاوی».
۱۸۹۷	کنار گذاشتن نظریهٔ اغوا؛ آغاز خودکاوی.
۱۸۹۹/۱۹۰۰	«تعبیر رؤیا».
۱۹۰۱	«روان‌آسیب‌شناسی زندگی روزمره».
۱۹۰۵	«سه رساله دربارهٔ نظریهٔ جنسیت»؛ «لطیفه و رابطهٔ آن با ناخودآگاه»؛ پروندهٔ دورا.
۱۹۰۸	نخستین کنگرهٔ بین‌المللی روانکاوی در سالزبورگ.
۱۹۰۹	سخنرانی در دانشگاه کلارک (آمریکا)؛ هانس کوچک و مرد موشی.
۱۹۱۰	تأسیس انجمن بین‌المللی روانکاوی.
۱۹۱۱	جدایی آدلر؛ پروندهٔ شرِبر.
۱۹۱۳	«توتم و تابو»؛ جدایی یونگ.
۱۹۱۴	«دربارهٔ خودشیفتگی».

۱۹۱۷	«سوگ و مالیخولیا».
۱۹۲۰	«فراسوی اصل لذت»؛ طرح سائق مرگ.
۱۹۲۳	«من و نهاد»؛ آغاز سرطان فک.
۱۹۲۶	«بازدارنده‌ها، نشانه‌ها و اضطراب»؛ «پرسش تحلیل غیرپزشکان».
۱۹۲۷	«آیندهٔ یک پندار».
۱۹۳۰	«ناخشنودی‌های تمدن»؛ دریافت جایزهٔ گوته.
۱۹۳۳	سوزاندن کتاب‌های فروید در آلمان نازی.
۱۹۳۸	الحاق اتریش و مهاجرت به لندن.
۱۹۳۹	«موسی و یکتاپرستی»؛ درگذشت در ۲۳ سپتامبر.

پیوست ب: واژه‌نامه

واژه‌های کلیدی نظریهٔ فروید با معادل انگلیسی و تعریفی کوتاه.

واژه	تعریف
ناخودآگاه Unconscious	ناحیه‌ای از روان با محتوای سرکوب‌شده که مستقیم در دسترس آگاهی نیست و رفتار را تحت تأثیر می‌گذارد.
پیش‌آگاه Preconscious	محتوایی که اکنون در ذهن نیست اما به‌آسانی قابل فراخوانی است.
سرکوب Repression	راندن محتوای ناپذیرفتنی به ناخودآگاه؛ بنیان‌ترین دفاع.
نهاد Id	مخزن سائق‌ها؛ تابع اصل لذت.
من Ego	کارگزار واقعیت و وساطت‌گر میان نهاد، فرامن و جهان بیرون.
فرامن Superego	وجدان و آرمان‌های درونی‌شده.
اصل لذت Pleasure principle	گرایش به تخلیهٔ فوری تنش و دوری از ناخوشی.
اصل واقعیت Reality principle	به‌تعویق انداختن ارضا برای سازگاری با واقعیت.
لیبیدو Libido	انرژی سائق جنسی (به معنای وسیع).
اروس Eros	سائق‌های زندگی؛ پیوند و حفظ.

سائق مرگ Death drive	گرایش به تخریب و بازگشت به حالت بی‌جان.
فرایند نخستین Primary process	شیوهٔ کار ناخودآگاه: تراکم، جابه‌جایی، بی‌زمانی.
تراکم Condensation	فشرده‌شدن چند معنا در یک تصویر.
جابه‌جایی Displacement	انتقال بار هیجانی از هدف اصلی به هدف دیگر.
تثبیت Fixation	ماندن بخشی از لیبیدو در یک مرحلهٔ رشد.
پسروی Regression	بازگشت به الگوهای مرحلهٔ پیشین رشد.
عقدهٔ ادیپ Oedipus complex	مثلث میل و رقابت کودک با والدین در مرحلهٔ آلتی.
والایش Sublimation	هدایت سائق به فعالیتی اجتماعاً پذیرفته.
سازش Compromise formation	پیامد کشمکش: علامت، رؤیا یا لغزش که هم میل را بیان و هم سانسور می‌کند.
اجبار به تکرار Repetition compulsion	گرایش به بازآفرینی تجربه‌های دردناک گذشته.
تداعی آزاد Free association	گفتن هر آنچه به ذهن می‌رسد، بدون سانسور.
انتقال Transference	بازآفرینی احساسات نسبت به افراد مهم گذشته بر تحلیل‌گر.
مقاومت Resistance	هر آنچه مانع رسیدن به محتوای سرکوب‌شده می‌شود.
محتوای آشکار / نهفته Manifest / Latent	لایهٔ ظاهری رؤیا در برابر معنای پنهان آن.

پیوست پ: کتاب‌شناسی

آثار اصلی فروید و منابعی برای مطالعهٔ بیشتر. ویراست مرجع آثار فروید به انگلیسی، «ویراست استاندارد» (Standard Edition، ۲۴ جلد) به سرپرستی جیمز استریچی است.

آثار اصلی فروید

۱۸۹۵	مطالعاتی دربارهٔ هیستری (با بروئر) — Studies on Hysteria
۱۹۰۰	تعبیر رؤیا — Die Traumdeutung
۱۹۰۱	روان‌آسیب‌شناسی زندگی روزمره — Zur Psychopathologie des Alltagslebens
۱۹۰۵	سه رساله دربارهٔ نظریهٔ جنسیت — Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie
۱۹۰۵	لطیفه و رابطهٔ آن با ناخودآگاه — Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten
۱۹۱۳	توتم و تابو — Totem und Tabu
۱۹۱۴	درآمدی بر خودشیفتگی — Zur Einführung des Narzissmus
۱۹۱۵	سائق‌ها و دگرگونی‌های‌شان؛ سرکوب؛ ناخودآگاه (مقالات متاروان‌شناسی)
۱۹۱۷	سوگ و مالیخولیا — Trauer und Melancholie
۱۹۲۰	فراسوی اصل لذت — Jenseits des Lustprinzips
۱۹۲۱	روان‌شناسی توده و تحلیل من — Massenpsychologie und Ich-Analyse
۱۹۲۳	من و نهاد — Das Ich und das Es
۱۹۲۶	بازدارنده‌ها، نشانه‌ها و اضطراب — Hemmung, Symptom und Angst
۱۹۲۷	آیندهٔ یک پندار — Die Zukunft einer Illusion
۱۹۳۰	ناخشنودی‌های تمدن — Das Unbehagen in der Kultur
۱۹۳۳	درس‌گفتارهای مقدماتی جدید دربارهٔ روانکاوی

۱۹۳۹ موسی و یکتاپرستی — Der Mann Moses und die monotheistische Religion

برای مطالعهٔ بیشتر

- پیتر گی، «فروید: زندگی برای زمانهٔ ما» (۱۹۸۸): زندگی‌نامهٔ جامع و متوازن.
- ارنست جونز، «زندگی و آثار زیگموند فروید» (۱۹۵۳ – ۱۹۵۷): زندگی‌نامهٔ رسمی از زبان نزدیک‌ترین شاگرد؛ ستایشگر.
- هانری الینبرگر، «کشف ناخودآگاه» (۱۹۷۰): تاریخ عظیم ایده‌های ناخودآگاه پیش از و پس از فروید.
- لاپلانش و پونتالیس، «زبان روانکاوی» (۱۹۶۷): فرهنگ دقیق مفاهیم.
- فرانک سالووی، «فروید، زیست‌شناس ذهن» (۱۹۷۹): ریشه‌های زیستی نظریه؛ نقدی تاریخی.
- فردریک کروز، «فروید: ساخت یک پندار» (۲۰۱۷): نقد تند.
- مارک سولمز و اورنا تورنبول، «مغز و جهان درون» (۲۰۰۲): پیوند علوم اعصاب و روانکاوی.
- جولیت میچل، «روانکاوی و فمینیسم» (۱۹۷۴): دفاع از فروید در برابر نقد فمینیستی.

این سند مرور تحلیلی نظریهٔ فروید است و جایگزین آثار خود او نیست.
برای هر مسئلهٔ بالینی یا روانی شخصی، به متخصص سلامت روان مراجعه کنید.